

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

APGAR FAMILIAR (FAMILY APGAR)

Eje IV: Recursos y Funcionamiento Familiar • Cribado Breve de Funcionalidad Familiar en Salud Mental

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL INSTRUMENTO

Nombre Oficial (Español)	Cuestionario de APGAR Familiar (Evaluación de Funcionalidad Familiar).
Nombre Original	Family APGAR Questionnaire (Smilkstein, 1978).
Autor Original	Dr. Gabriel Smilkstein, M.D. (Department of Family Medicine, University of Washington, EE.UU.).
Adaptación Hispana	Bellón, Delgado, Luna y Lardelli (1996); Granada, España (validación de referencia).
Eje Clínico y Constructo	Eje IV: Funcionamiento, Familia y Recursos. Percepción subjetiva de la funcionalidad y apoyo familiar.
Tipo de Instrumento	Autoinforme ultracorto de 5 ítems graduados en escala ordinal de 3 niveles (0 a 2 puntos).
Población y Rango	Adolescentes y adultos (desde 12 años). Población general, atención primaria y salud mental.
Tiempo de Administración	2 a 3 minutos en administración autoadministrada o heteroaplicada.
Régimen de Licencia	Dominio público / Uso clínico y de investigación abierto con citación obligatoria.

2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL: EL MODELO APGAR DE DINÁMICA FAMILIAR

El **APGAR Familiar** fue desarrollado por Gabriel Smilkstein (1978) bajo el principio de que la familia opera como el microsistema psicosocial primario modulador de la vulnerabilidad ante la enfermedad médica y psiquiátrica. Inspirado metafóricamente en el célebre test neonatal de Virginia Apgar, el instrumento propone un acrónimo de cinco parámetros cardinales de la dinámica familiar percibida:

1. **Adaptabilidad (Adaptation):** Capacidad del sistema familiar para movilizar recursos internos y externos en situaciones de crisis o estrés.
2. **Participación / Cooperación (Partnership):** Grado de corresponsabilidad y reciprocidad en la comunicación y toma de decisiones compartidas.
3. **Gradiente de Desarrollo / Maduración (Growth):** Aceptación y acompañamiento del crecimiento biopsicosocial y la autonomía de cada miembro.
4. **Afecto (Affection):** Calidad e intensidad de la resonancia afectiva íntima, permitiendo la expresión franca de amor, tristeza, angustia y ternura.
5. **Resolución / Capacidad Resolutiva (Resolve):** Compromiso de tiempo, apoyo instrumental y devoción mutua para solucionar dificultades cotidianas.

3. DOMINIOS EVALUADOS Y COMPOSICIÓN DE ÍTEMS (5 REACTIVOS)

Componente APGAR	Ítem	Enunciado Operativo Evaluado en la Versión Española (Bellón et al.)
Adaptabilidad	Ítem 1	¿Está satisfecho con la ayuda que recibe de su familia cuando tiene un problema?
Participación	Ítem 2	¿Conversan entre ustedes los problemas que tienen en casa?
Gradiente de Desarrollo	Ítem 3	¿Las decisiones importantes se toman en conjunto en la familia?
Afecto	Ítem 4	¿Está satisfecho con el tiempo que su familia pasa con usted?
Resolución	Ítem 5	¿Siente que su familia le quiere y le apoya cuando está triste o angustiado?

PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS Y BAREMACIÓN CLÍNICA

4. VALIDEZ, CONFIABILIDAD Y RENDIMIENTO DIAGNÓSTICO EN ESPAÑA / LATAM

La validación española de Bellón et al. (1996; $N = 393$ usuarios de atención primaria) demostró un rendimiento métrico intachable:

Propiedad Psicométrica	Coefficiente / Métrica	Interpretación Metodológica y Evidencia Empírica
Consistencia Interna	Alfa $\alpha = 0.84$	Elevada homogeneidad interna para una escala ultracorta de solo 5 reactivos.
Estabilidad Temporal	Test-retest $r = 0.81$	Alta reproducibilidad en reevaluaciones a 2 y 4 semanas en pacientes estables.
Estructura Factorial	Unidimensional (CFA)	Un único factor general explica más del 62% de la varianza total acumulada.
Validez de Criterio	$r = 0.64$ (Duke-UNC)	Fuerte correlación con escalas de apoyo social funcional y el cuestionario FACES.
Validez Discriminante	Significativo ($p < 0.001$)	Discrimina nítidamente entre pacientes con somatizaciones y población sana.

5. REGLAS DE CORRECCIÓN Y CÁLCULO DE PUNTUACIONES

- **Opciones de Respuesta Estándar:** La adaptación española validada de Bellón et al. utiliza tres alternativas ordinales graduadas:
 - **Casi nunca:** 0 puntos.
 - **A veces:** 1 punto.
 - **Casi siempre:** 2 puntos.
- **Cálculo Total Directo:** Se calcula la suma aritmética simple de los 5 reactivos del cuestionario:

$$\text{Puntuación Total APGAR} = \sum_{i=1}^5 \text{Ítem}_i \quad (\text{Rango: 0 a 10 puntos})$$

- **Tratamiento de Omisiones:** Dado que consta de solo 5 ítems, la omisión de un único reactivo invalida el cálculo directo; requiere aclaración verbal inmediata por el profesional clínico.

6. BAREMOS NORMATIVOS, PUNTOS DE CORTE Y ESTRATIFICACIÓN FUNCIONAL

Estratificación	Rango PD	Diagnóstico Familiar	Significación Clínica y Repercusión Terapéutica
Buena Función	7 a 10 pts	Familia Normofuncional	Vínculos afectivos sólidos; recurso protector de apoyo y resiliencia.
Disfunción Leve/Mod.	4 a 6 pts	Disfunción Familiar Moderada	Tensiones vinculares activas; fallas en comunicación o apoyo percibido.
Disfunción Severa	0 a 3 pts	Disfunción Familiar Severa	Colapso del sistema de apoyo; violencia, negligencia o ruptura del vínculo.

ALERTA DE DISFUNCIÓN FAMILIAR GRAVE (PUNTUACIÓN ≤ 3 PUNTOS):

Una puntuación en el APGAR Familiar de **0 a 3 puntos** indica la inexistencia o toxicidad del sostén psicosocial íntimo, correlacionando con un riesgo 4 veces mayor de refractariedad en trastornos afectivos, abandono terapéutico y descompensaciones somáticas frecuentes.

APLICACIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO Y REFERENCIAS

7. ALGORITMO DE ACTUACIÓN CLÍNICA SEGÚN EL APGAR FAMILIAR

PROTOCOLO DE ENCUADRE TERAPÉUTICO Y DERIVACIÓN FAMILIAR:

- **Paso 1 (Cribado en Línea Base):** Administrar en la primera consulta de salud mental para mapear el capital psicosocial del consultante.
- **Paso 2 (Interpretación de Puntuación ≥ 7):** Incorporar a la familia como aliada coterapéutica activa en el plan de cuidados (supervisión de medicación, acompañamiento en activación conductual).
- **Paso 3 (Manejo de Disfunción Moderada [4-6]):** Identificar qué ítems obtuvieron 0 puntos (ej. falta de afecto vs. falta de diálogo). Plantear intervenciones psicoeducativas breves de comunicación asertiva intrafamiliar.
- **Paso 4 (Manejo de Disfunción Severa [0-3]):** Descartar maltrato intrafamiliar o violencia doméstica activa. No forzar entrevistas familiares conjuntas si el entorno es hostil; derivar a terapia familiar sistémica especializada y conectar con recursos de apoyo social externos.

8. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO: SOMATIZACIONES PERSISTENTES Y DESAMPARO AFECTIVO

Identificación: Mujer de 42 años, administrativa, derivada por médico de cabecera tras múltiples consultas por cefaleas tensionales refractarias, dolor epigástrico inespecífico e insomnio crónico sin hallazgos orgánicos patológicos.

Evaluación Psicométrica Inicial:

- **APGAR Familiar Total = 2 / 10 puntos (Disfunción Familiar Severa).**
- **Adaptabilidad:** 0 puntos (Casi nunca recibe auxilio ante adversidades).
- **Participación:** 0 puntos (Las decisiones son impuestas unilateralmente por el cónyuge sin consulta).
- **Gradiente de Crecimiento:** 1 punto (A veces se tolera su iniciativa profesional).
- **Afecto:** 0 puntos (Casi nunca experimenta afecto o contención afectiva).
- **Resolución:** 1 punto (A veces resuelven crisis económicas urgentes).

Formulación e Intervención: Se diagnosticó Trastorno de Síntomas Somáticos reactivo a un entorno conyugal invalidante y hostil. La paciente expresaba somáticamente la angustia reprimida ante la incomunicación intrafamiliar. Se estructuró un plan de terapia cognitivo-conductual individual enfocado en asertividad y límites, complementado con 6 sesiones de mediación vincular.

Reevaluación a los 6 Meses: El APGAR Familiar se incrementó a **7 / 10 puntos** tras acordar espacios semanales de diálogo y reestructuración de la convivencia conyugal, con una reducción del 75% en la frecuencia de las cefaleas.

9. ALERTAS DE SEGURIDAD Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

SOSPECHA DE VIOLENCIA DE GÉNERO:

Un APGAR Familiar de 0 a 2 puntos en una mujer que presenta lesiones físicas dudosas o aislamiento social impuesto obliga a activar de oficio el protocolo sanitario de violencia de género.

SUBJETIVIDAD INDIVIDUAL EN EL APGAR:

El instrumento mide la **percepción individual**, no la realidad objetiva global. Distintos miembros de la misma familia pueden puntuar 2 y 9 puntos respectivamente según su rol en la dinámica.

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS CIENTÍFICAS

1. Smilkstein, G. (1978). The family APGAR: A proposal for a family function test and its use by physicians. *Journal of Family Practice*, 6(6), 1231-1239.
2. Bellón, J. A., Delgado, A., Luna, J. D., & Lardelli, P. (1996). Validez y fiabilidad del cuestionario de función familiar Apgar-familiar. *Atención Primaria*, 18(6), 289-295.
3. Smilkstein, G., Ashworth, C., & Montano, D. (1982). Validity and reliability of the family APGAR as a test of family function. *Journal of Family Practice*, 15(2), 303-311.
4. Forgays, D. K. (2001). The Family APGAR: Diagnostic efficiency with psychiatric and somatic outpatients. *Journal of Clinical Psychology*, 57(9), 1145-1153.